

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TERMINASI TINDAKAN HEMODIALISIS		
	No. Dokumen 130/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/4

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 3 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS
Pengertian	Tindakan untuk menyelesaikan proses hemodialisis	
Tujuan	Mengakhiri tindakan hemodialisis dengan aman, tepat dan sesuai	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024	
Prosedur	A. Persiapan alat dan bahan 1. Tutup dialiser 2. NaCL 0,9% 500-1000 cc 3. Heparin dan gentamisin / citralock 4. Kassa / deppers 5. S spuit 3 cc dan 20 cc 6. Alcohol swab/spray 7. Handscoon 8. Safety box 9. Ember tempat HF single use 10. Plester dan gunting 11. Tensimeter B. Penatalaksanaan 1. Pastikan bahwa waktu hemodialisis telah selesai ditandai dengan alarm pada mesin berbunyi 2. Lakukan cuci tangan dan pakai APD 3. Siapkan NaCL 0,9% untuk membilas 4. Ambil spuit 20 cc dari port heparin 5. Tutup selang heparin dengan plug 6. Ambil infus set, tutup infus line dengan plug 7. Bilas spuit 20 cc dengan NaCL 0,9% menggunakan konektor, kemudian isi dengan 5-10 cc NaCL 0,9% 8. Tekan "RETRANS – BY PASS – RESET (UF REMOVE)" kemudian turunkan blood pump sampai nol 9. Matikan blood pump 10. Ada dua metode yang bisa digunakan saat menyambungkan blood line dengan NaCL: a) Metode dengan konektor	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TERMINASI TINDAKAN HEMODIALISIS		
	No. Dokumen 130/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/4
	Klem infus line, blood line arteri (ABL) dan inlet. Sambungkan ABL dengan infus set NaCL 0,9% menggunakan konektor, buka klem NaCL 0,9% dan ABL b) Metode tanpa konektor Klem inlet dan ABL, buka klem infus line NaCL 0,9% yang terhubung dengan blood line 11. Posisikan dialiser biru diatas dan merah dibawah 12. Nyalakan blood pump dengan kecepatan 100-150 mL/menit 13. Bila ada obat injeksi yang diberikan, masukkan pada medication port/latek venous blood line (VBL) 14. Matikan blood pump bilamana darah dalam VBL sudah tergantikan oleh NaCL 0,9%, kemudian klem outlet dan VBL 15. Ukur TTV pasien, bila tidak ada masalah lepaskan outlet dengan VBL 16. Ada 2 metode dalam membilas inlet: a) Metode dengan konektor Buka klem inlet dan dorong darah yang tersisa di fistula inlet dengan spuit 20 cc yang terisi NaCL 0,9% kemudian tutup dengan plug b) Metode tanpa konektor Buka klem inlet dan berikan tekanan gravitasi pada flabot NaCL 0,9% dan tutup dengan plug 17. Jika pasien terpasang akses AV Fistula Perawat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Siapkan dan dekatkan semua peralatan yang akan dipakai b) Lepaskan fistula outlet dan inlet, tutup dan tekan luka dengan depper minimal 5 menit atau sesuai dengan kondisi pasien c) Buang jarum AV fistula bekas kedalam safety box d) Setelah darah berhenti, fiksasi depper menggunakan plester e) Rapikan alat 18. Jika pasien terpasang akses Vena Femoralis Perawat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Siapkan dan dekatkan peralatan yang akan dipakai b) Lepaskan jarum AV fistula outlet, tutup dan tekan sekitar 15 menit atau sesuai dengan kondisi pasien c) Lepaskan jarum AV Fistula pada femoral, tutup dan tekan dengan depper selama 15 menit atau sesuai dengan kondisi pasien d) Setelah darah berhenti, fiksasi depper dengan plester e) Buang jarum AV Fistula kedalam safety box		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TERMINASI TINDAKAN HEMODIALISIS		
	No. Dokumen 130/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 3/4
	f) Rapihan alat 19. Jika pasien terpasang double lumen catheter (DLC) Perawat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: - Pastikan inlet dan outlet DLC dalam posisi di klem - Masukan NaCL 0,9% kedalam inlet dan outlet DLC sampai bersih - Setelah NaCL 0,9% masuk, tidak boleh dilakukan aspirasi - Masukan heparin dengan perbandingan 1000 unit: 1ml NaCL 0,9% kedalam spuit 10 cc masing masing kedalam inlet dan outlet DLC sesuai ukuran DLC - Sangat penting untuk melakukan heparin dengan jumlah yang tepat sehingga tidak ada kelebihan heparin yang dapat masuk dalam sirkulasi darah pasien, dilakukan dan didorong dengan cepat - Bila pasien banyak keringat atau perdarahan dari tempat insersi, disarankan untuk tidak menggunakan semi permeable dressing, cukup dengan kassa steril - Semipermeable dressing dapat diganti 1 minggu sekali - Bersihkan ujung DLC dengan kasa alkohol - Pasang tutup DLC dan balut dengan kasa steril - Rapihan alat 20. Apabila fistula telah selesai dilepaskan, perawat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: - Masukan tubing konsentrat dialisat pada rinse port dan lepaskan chart bikarbonat - Lakukan proses drain: tekan "DRAIN" kemudian lepas kopler biru dan kembalikan kopler ke mesin port. Tutup dialiser biru dengan penutup dialiser bila proses drain selesai - Bila menggunakan AK1 maka lakukan drain pada powder dengan cara: masuk RINSE MODE dan lihat cairan di powder tunggu sampai dengan tampilan DRAIN FINISH di monitor - Lakukan desinfeksi (RINSE MODE) pada mesin sesuai dengan SPO - Lepaskan selang darah (bloodline) dan masukan ke dalam ember/box HF reuse - Lepaskan handscoon dan lakukan cuci tangan - Rapihan alat 21. Evaluasi pasien post HD (TTV, timbang BB kering, perdarahan atau pembengkakan pada lokasi akses vaskular). Pastikan pasien stabil untuk dipulangkan. Bila terdapat kondisi kegawatdaruratan, seperti KU lemah, TTV tidak stabil,		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TERMINASI TINDAKAN HEMODIALISIS		
	No. Dokumen 130/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 4/4
	atau keluhan kegawatdaruratan yang lain, maka pasien bisa dipindahkan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) 22. Dokumentasikan kegiatan		
Unit Terkait	Unit Dialisis		